NEURO · NE-01

AVC ischémique aigu

AHA/ASA 2026

imagerie initiale, ASPECTS, fenêtres de thrombolyse et thrombectomie

IMAGERIE INITIALE · « LE TEMPS, C'EST DU CERVEAU »

1 · Parenchyme
Scanner sans injection ou IRM (diffusion, FLAIR, T2*) : exclure une hémorragie, évaluer l'infarctus constitué (ASPECTS)

›

2 · Vaisseaux
Angioscanner ou ARM de la crosse aortique au vertex si thrombectomie possible : occlusion d'un gros vaisseau (ACI, M1, M2, tronc basilaire)

›

3 · Perfusion (sélectif)
Scanner ou IRM de perfusion : 6–24 h, heure de début inconnue, viabilité incertaine. Ne doit pas retarder le traitement

Ne pas retarder : l'imagerie vasculaire ne doit pas attendre la **créatinine** (COR 1, AHA/ASA 2026).

Réveil ou heure inconnue : en IRM, un **mismatch diffusion–FLAIR** (lésion visible en diffusion, pas encore en FLAIR) suggère un début < 4,5 h et permet une thrombolyse chez des patients sélectionnés.

ASPECTS (TERRITOIRE DE L'ARTÈRE CÉRÉBRALE MOYENNE)

Partir de **10** et retirer **1 point par région** présentant une hypodensité ou une perte de différenciation précoce.

NIVEAU	10 RÉGIONS
Noyaux gris (coupe thalamo-striée)	C (caudé), L (lenticulaire), IC (capsule interne), I (insula), M1, M2, M3
Supra-ganglionnaire	M4, M5, M6

PC-ASPECTS (circulation postérieure) : 10 points, thalamus 1 chacun, lobe occipital 1 chacun, mésencéphale 2, pont 2, cervelet 1 chacun.

Interprétation

ASPECTS	SIGNIFICATION
6–10	Infarctus constitué limité
3–5	« Large core » : thrombectomie désormais recommandée dans des cas sélectionnés
0–2	Infarctus étendu : thrombectomie seulement dans des cas très sélectionnés

Lecture en fenêtre étroite (W ≈ 40, L ≈ 40), sur coupes fines ou reconstructions.

THROMBECTOMIE · CIRCULATION ANTÉRIEURE (ACI OU M1)

DÉLAI	CRITÈRES	RECOMMANDATION AHA/ASA 2026
0–6 h	NIHSS ≥ 6, mRS préalable 0–1, **ASPECTS 3–10**	**Recommandée** (nouveau, fort impact) ; ASPECTS 0–2 : raisonnable chez des patients sélectionnés
6–24 h	NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS ≥ 6**	**Recommandée**
6–24 h	Âge < 80 ans, NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS 3–5**, pas d'effet de masse significatif	**Recommandée** chez des patients sélectionnés (nouveau)
0–6 h	NIHSS ≥ 6, **ASPECTS ≥ 6**, **mRS préalable 2**	**Raisonnable** (2a, nouveau) pour réduire le handicap cumulé

Tronc basilaire

- Thrombectomie recommandée jusqu'à **24 h** si mRS 0–1, **NIHSS ≥ 10** et **PC-ASPECTS ≥ 6**
- NIHSS 6–9 : bénéfice incertain

Thrombolyse IV

- Dans les **4,5 h** si pas d'hémorragie : **altéplase 0,9 mg/kg** ou **ténectéplase 0,25 mg/kg (max 25 mg)** (COR 1)
- **4,5–9 h ou réveil** (début ≤ 9 h du milieu du sommeil) : raisonnable (2a) si **pénombre sur perfusion automatisée** — voir NE-04
- Si thrombectomie prévue : ne pas retarder la thrombolyse ni attendre la réponse clinique

COMPTE RENDU : À DONNER EN PREMIER

Hémorragie ?
oui / non, en premier

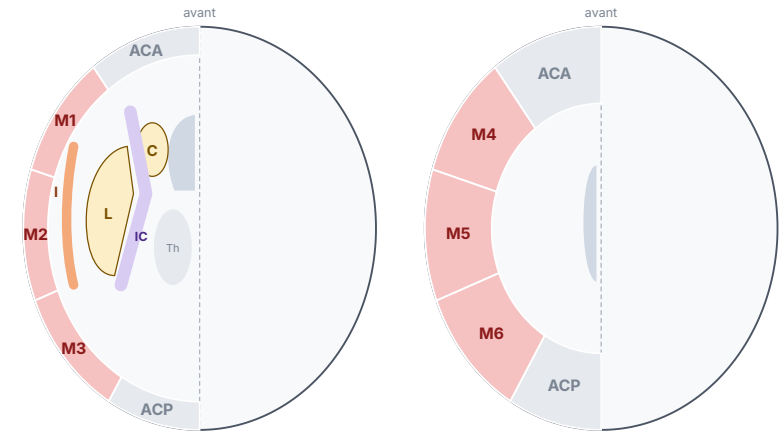
Occlusion
site exact (ACI, M1, M2, tronc basilaire), tandem, dissection

Infarctus constitué
ASPECTS, volume du cœur ischémique et mismatch si perfusion

Voie d'abord
crosse, tortuosités, sténose cervicale

AVC ischémique aigu (suite)

ATLAS VISUEL · LES 10 RÉGIONS ASPECTS



Niveau des noyaux gris (thalamo-striatal) — Niveau supra-ganglionnaire

Schéma simplifié, non à l'échelle · hémisphère droit du patient à gauche de l'image (convention radiologique)

Comment coter

- Lire sur **2 niveaux** : noyaux gris (thalamus, striatum) et supra-ganglionnaire, juste au-dessus des noyaux
- **Structures profondes** C caudé, L lenticulaire, IC capsule interne (3 points)
- **I** ruban insulaire (1 point)
- **Cortex** M1–M3 au niveau des noyaux, M4–M6 au-dessus (6 points)
- Retirer 1 point par région avec hypodensité ou perte de différenciation substance grise / blanche
- Les territoires ACA et ACP (gris) ne sont pas cotés

ASTUCE

Toute la région doit être examinée sur plusieurs coupes ; une atteinte partielle suffit à retirer le point.

SIGNES PRÉCOCES À RECONNAÎTRE

ACM hyperdense

Segment M1 ou M2 spontanément plus dense que le côté opposé (thrombus). Comparer à l'ACM controlatérale.

Voir un cas ↗

Ruban insulaire

Perte de la différenciation cortex / substance blanche de l'insula, l'un des signes les plus précoces.

Voir l'article ↗

Noyau lenticulaire

Effacement des contours du noyau lenticulaire, hypodensité des noyaux gris (atteinte des perforantes).

Voir des exemples ↗

Mismatch diffusion–FLAIR

Lésion visible en diffusion mais pas encore en FLAIR : début probable < 4,5 h.

Voir un cas ↗

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ASPECTS : article et images
Radiopaedia · régions, exemples annotés, PC-ASPECTS
radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programm

Calculateur ASPECTS
MDCalc · cocher les régions atteintes
www.mdcalc.com/calc/3164/alberta-stroke-program-

Signe de l'ACM hyperdense (cas)
Radiopaedia · thrombus spontanément dense
radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-16

Perte du ruban insulaire
Radiopaedia · signe précoce au scanner
radiopaedia.org/articles/loss-of-the-insular-rib

Mismatch diffusion–FLAIR (cas)
Radiopaedia · infarctus hyperaigu, AVC du réveil
radiopaedia.org/cases/hyperacute-mca-infarct-wit

PC-ASPECTS illustré
Radiopaedia · circulation postérieure
radiopaedia.org/cases/posterior-circulation-acut

Sources : AHA/ASA 2026 – Early Management of AIS (Stroke, texte intégral) – www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000513 · StatPearls – Acute Stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · Radiopaedia – ASPECTS – radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programme-early-ct-s...